

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062840-49.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** ALICE LEAL FERNANDES DAS CHAGAS

**RECORRIDO:** RAPHAEL FERNANDES DAS CHAGAS

**AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM PEDIATRIA. LEITES ESPECIAIS. INSUMO NEOCATE. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5062840-49.2024.4.02.5101

510014319992 .V3

**RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062840-49.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**RECORRIDO:** ALICE LEAL FERNANDES DAS CHAGAS

**RECORRIDO:** RAPHAEL FERNANDES DAS CHAGAS

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União Federal a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada, na forma da decisão recorrida, que determinou que os réus, dentro de suas esferas de competências administrativas, forneçam à parte Autora **Consulta em pediatria - leites especiais, bem como o insumo Neocate**.

Em suas razões recursais, a União sustenta ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Alega que a legislação veda as aquisições de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS a partir da indicação de seu nome comercial. Requer a cassação da antecipação dos efeitos da tutela ou, na eventualidade de manutenção da tutela provisória de urgência, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Município.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

**VOTO**

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

*“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:*

*I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.” (grifo nosso)”*

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

*Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:*

*(...)*

*IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:*

*a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;*

***b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;(…)***

No caso em tela, a autora, menor impúbere, apresenta alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e sensibilidade à proteína de soja, está em acompanhamento nutricional no Instituto Fernandes Figueira (IFFFIOCRUZ). Atualmente, faz uso de fórmula de aminoácidos, apresentando melhora no quadro de diarreia, refluxo gastroesofágico e dermatite atópica. A continuidade do tratamento com a aludida intervenção nutricional é imprescindível para que possa corrigir as consequências provocadas pelas doenças e ter um crescimento e desenvolvimento adequado.

O parecer técnico da CRLS informa que as vagas para Consulta em pediatria - leites especiais são gerenciadas através no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) e, ao se consultar o referido sistema, foi localizada a demanda da autora, sob o ID 507833723, inserida em 30/11/2023 pelo CMS NAGIB JORGE FARAH AP 31, com a Classificação de Risco AMARELO, com status PENDENTE. No dia 18/04/2024, houve a resposta da regulação de que não há vagas e que o RISCO foi alterado para AZUL. A classificação AZUL é adequada a Crianças portadoras de Alergia Alimentar com idade maior que dois anos, **o que não é o caso da autora, nascida em 13/01/2023.**

O parecer do NAT, evento 8 dos autos originários, confirma a indicação do tratamento pleiteado para a patologia que acomete a parte autora, vejamos:

### **III – CONCLUSÃO**

1. Inicialmente, cabe esclarecer que na inicial (Evento 1, INIC1, Página 10) foi solicitada **Consulta em Pediatria – Leites Especiais**. Tal consulta não está relacionada somente ao atendimento do profissional em pediatria, mas sim ao acompanhamento através do **Programa de Assistência à Criança Portadora de Diarreia Persistente (PRODIAPE), com disponibilização de fórmulas alimentares especializadas**.
2. Ressalta-se que a **Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ)** dispõe do **PRODIAPE**, presente no **Hospital Municipal Jesus (HMJ)** (Rua Oito de Dezembro, 717, Vila Isabel), que apresenta equipe multiprofissional responsável pelo atendimento e acompanhamento de crianças com quadros clínicos específicos (portadoras ou com suspeita de alergia alimentar, má absorção ou diarreias crônicas a esclarecer) residentes no município do Rio de Janeiro.
3. No **PRODIAPE podem ser fornecidas fórmulas especializadas** (com restrição de lactose, à base de proteína do leite extensamente hidrolisada, à base de proteína isolada de soja, ou à base de aminoácidos livres), conforme avaliação técnica e segundo protocolos estabelecidos, **até o paciente completar 2 anos de idade**.
4. Participa-se que apesar da **Consulta em Pediatria – Leites Especiais**, pleiteada (Evento 1, INIC1, Página 10) não se encontrar prescrita pelo médico assistente (Evento 1, ANEXO2, Página 15), elucida-se que para obtenção de fórmulas infantis por meio do **PRODIAPE é necessário o atendimento no programa**.
5. Dessa forma, ressalta-se que, diante do quadro clínico e faixa etária da Autora, a **Consulta em Pediatria – Leites Especiais está indicada**.
6. Para a inclusão no PRODIAPE, deve ser feita a inserção no **Sistema Nacional de Regulação (SISREG)** como **Consulta em Pediatria – Leites Especiais**, a qual deve ser realizada pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.
7. Nesse contexto, em consulta ao **Sistema Nacional de Regulação (SISREG)**, verificou-se que a Autora foi cadastrada sob o código de solicitação nº 507833723 para consulta em pediatria – leites especiais em 30 de novembro de 2023 pelo Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah, classificação de risco amarelo – urgência e **encontra-se atualmente em situação pendente**, uma vez que **não há vagas no momento**.

<sup>6</sup> Coordenação de Serviços de Saúde – AP 2.2. Superintendência de Serviços de Saúde. Hospital Municipal Jesus. Memorando 03/14, emitido em 20 de fevereiro de 2014, direcionado à Direção e Chefe de Especialidades.

<sup>7</sup> Danone. Aplicativo Soluções Nutricionais. Ficha técnica do Neocate® LCP.



No entanto, com relação à quantidade requerida de 12 latas/mês, o Núcleo é categórico ao informar que **07 latas de 400g/mês são suficientes para a ingestão calórica de que o autor necessita**.

Superada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada deferida pelo Juízo *a quo*.

O deferimento do efeito suspensivo tem por objetivo impedir a ocorrência de dano de difícil reparação até o pronunciamento definitivo do colegiado.

Nesse contexto, analisando o presente caso, não vislumbro qualquer possibilidade de dano irreparável à recorrente, cujas razões recursais apenas atacam o provimento antecipatório sem demonstrar fatos hábeis que pudessem afastar a verossimilhança da pretensão autoral.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC e entendo que os argumentos da União não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.